

Bevægeapparatets sygdomme

Tine Alkjær, lektor
Biomedicinsk Institut
Email: talkjaer@sund.ku.dk

Læringsmål: Kendskab til de mest almindelige sygdomme i bevægeapparatet

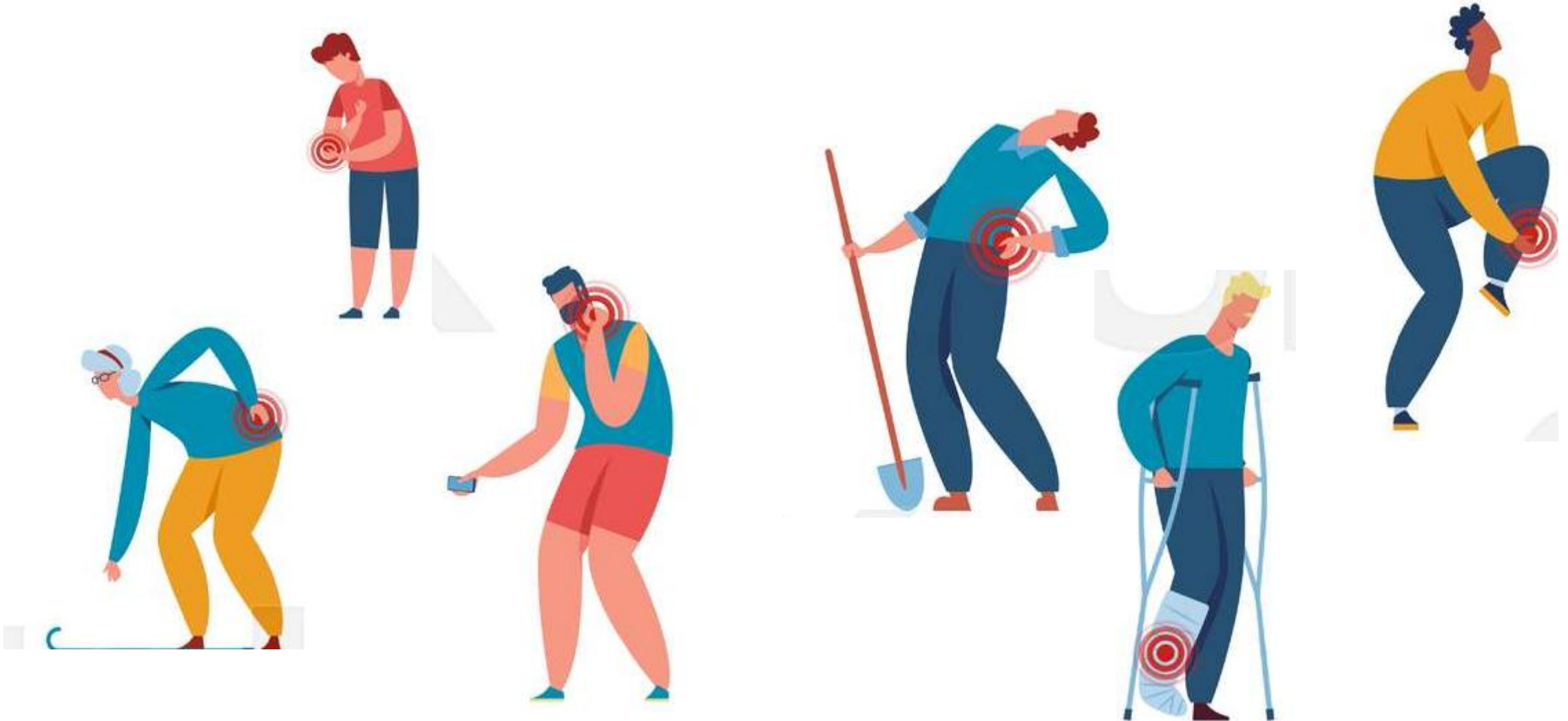
- **Definere** sygdommene.
- Forklare **patogenese** og **ætiologi**.
- Beskrive **symptomer/fund, diagnostik, behandling, forebyggelse** og **byrde** for **patient** og **samfund**.
- Nævne **forekomst, følgesygdomme** og **prognose**.

Hvad man skal kunne om de enkelte sygdomme på pensum?

Definition	Forekomst	Patogenese	Ætiologi	Symptomer og Fund
Kort, præcis definition af hvad sygdommen er	Er det en hyppig sygdom, en sjælden sygdom, eller en derimellem? Hvem rammes?	De forandringer der fører til udvikling af sygdommen (sygdomsproces)	Sygdommens årsager Hvad disponerer for sygdommen?	Hvad patienten kunne beklage sig over til lægen Hvad lægen vil kunne se på patienten eller mærke sig frem til

Parakliniske undersøgelser	Behandling	Følgesygdomme	Prognose	Byrde
Blodprøver, billeddiagnostik, lungfunktions-undersøgelser og så videre	Principper for behandling, medicin med videre	Sygdomme der hyppigere rammer patienter med denne sygdom	Fremtidsudsigter, overlevelsese-rate, helbredelsesrate?	Byrde for patient og/eller samfund

Fællesnævner for bevægeapparatets sygdomme: Smerte, stivhed og tab af funktion



Tusindvis er plaget af smerter i kroppen ; hver 5. dansker har kroniske smerter

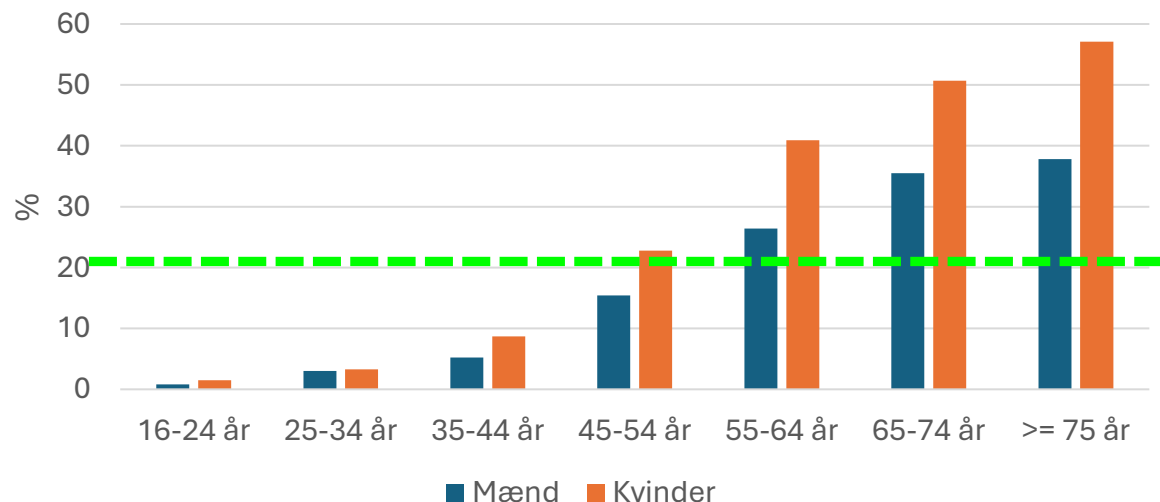


Tabel 4.2.1 Andel med specifikke sygdomme og helbredsproblemer (det vil sige har den pågældende sygdom eller stadig har eftervirkninger af sygdommen). 2010, 2013, 2017, 2021 og 2023. Procent

		2010	2013	2017	2021	2023
Artrose	Allergi	21,9	22,7	21,9	23,6	24,7
	Slidgigt	19,7	19,7	20,9	22,5	22,8
	Forhøjet blodtryk	18,0	18,4	18,9	20,5	22,3
	Tinnitus	10,1	12,1	12,7	16,1	18,6
	Migræne eller hyppig hovedpine	15,7	14,5	16,3	17,9	16,6
	Psykisk lidelse	-	9,0	10,9	12,9	16,2
	Diskusprolaps eller andre rygsygdomme	13,6	13,3	13,7	14,8	15,6
Reumatoid artrit	Angst	-	-	-	12,3	15,0
	Depression	-	-	-	13,2	14,8
	Astma	7,6	7,5	7,6	8,5	8,6
	Leddegigt	6,0	6,0	6,8	7,9	8,1
	Diabetes	4,9	5,2	5,5	5,8	6,3
	Grå stær	3,8	4,1	4,4	5,1	5,9
	Kronisk lungesygdom	4,6	4,4	4,3	5,2	4,9
	Osteoporose (knogleskørhed)	3,2	3,4	3,9	4,5	4,9
	Kræft	2,3	2,6	3,2	3,7	4,1
	Hjertekrampe	2,1	1,8	1,9	2,2	2,4
	Hjerneblødning	1,5	1,5	1,7	2,0	1,9
	Blodprop i hjertet	1,2	1,1	1,2	1,3	1,4

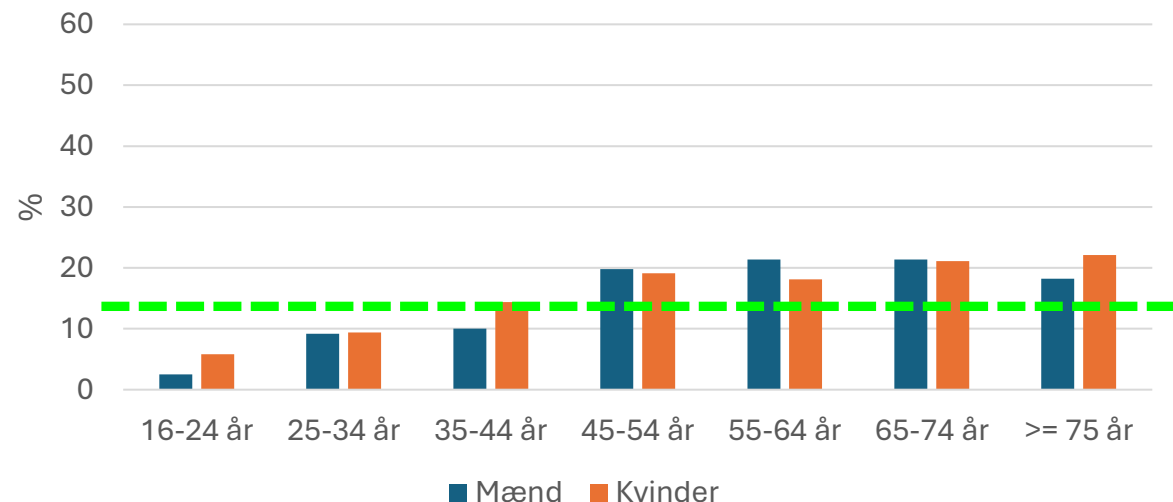
Danskernes sundhed 2010, 2013, 2017, 2021 og 2023

Andel med osteoartrose (OA, slidgigt)



Bemærk: Datakilden *Danskernes Sundhed 2023* er baseret på selvrapporterede oplysninger i spørgeskemaer – dvs. borgerne angiver selv, om de har en given sygdom.

Andel med rygsygdomme



Forekomst

hvem rammes (i forhold til alder, køn, geografi mm)

Prævalens

hvor mange er ramt i en given population

Bevægeapparatets sygdomme: Kapitel 3 i lærebogen



Gigtsygdomme

Opstår, når biologiske processer som **inflammation** eller **degeneration** gradvist ødelægger vævet.

F2: Inflammatoriske ledsygdomme

F3: Degenerative ledsygdomme



Vævsskader

Opstår, når en **ydre belastning** overstiger vævets styrke eller evne til at tilpasse sig.

F4: Vævsskader

Bevægeapparatet - repetition

Forklar hinanden:

Hvad er bevægeapparatet?



Bevægeapparatet - repetition



**Knogler, led, muskler, sener, nerver og kar,
der muliggør bevægelse**

Skelettets (knoglernes) funktioner

Støtte og beskyttelse

- Giver stivhed og styrke til kroppen.
- Beskytter vitale organer som hjerne og rygmarv.
- Bestemmer kroppens form.

Depot for

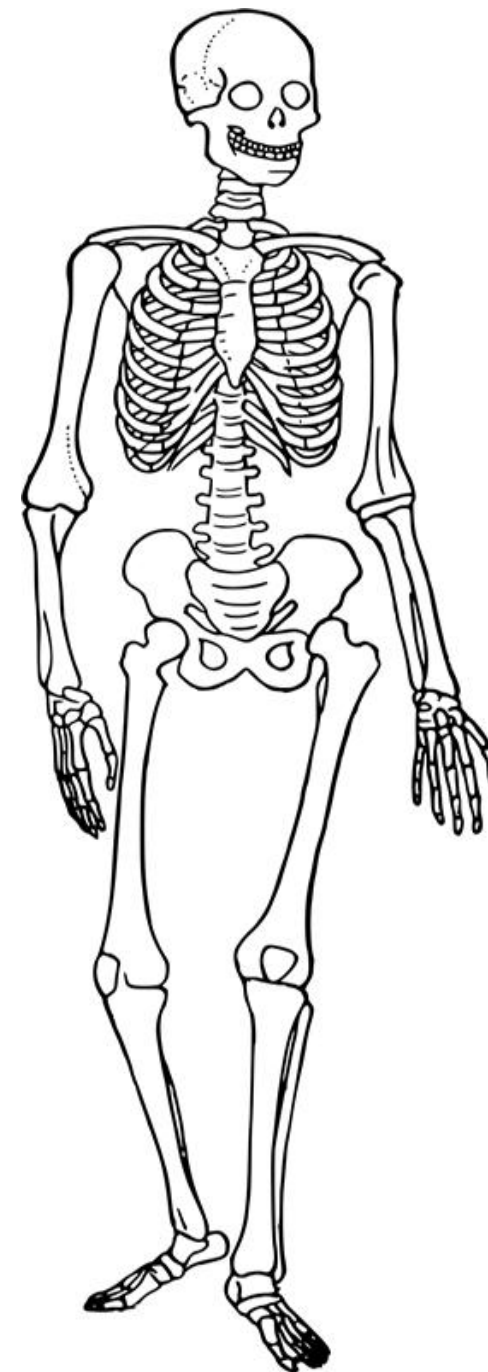
- Kalk.
- Knoglemarv.

Tilpasning

- Plastiske og formbar afhængigt af belastning.
- Letvægtskonstruktion → maksimal styrke & minimal vægt.

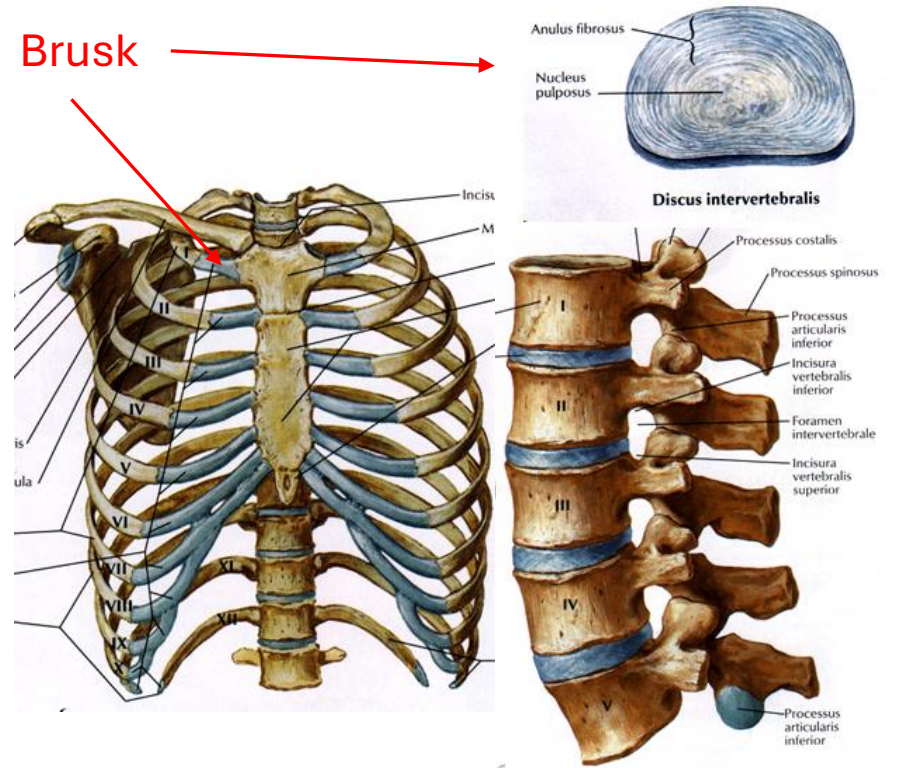
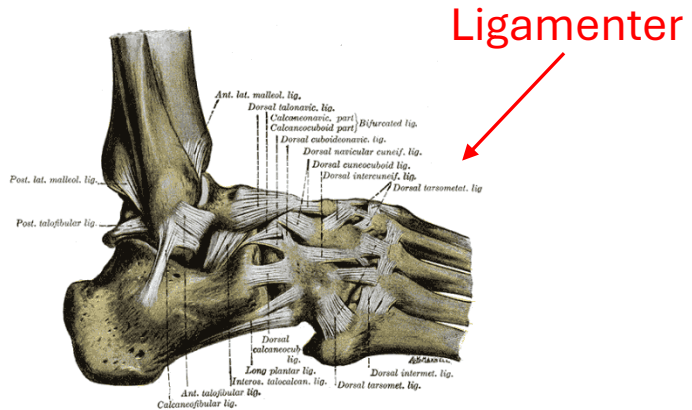
Led og bevægelse

- Danner led hvor de mødes og muliggør bevægelse.
- Fungerer som vægtstænger for musklerne.



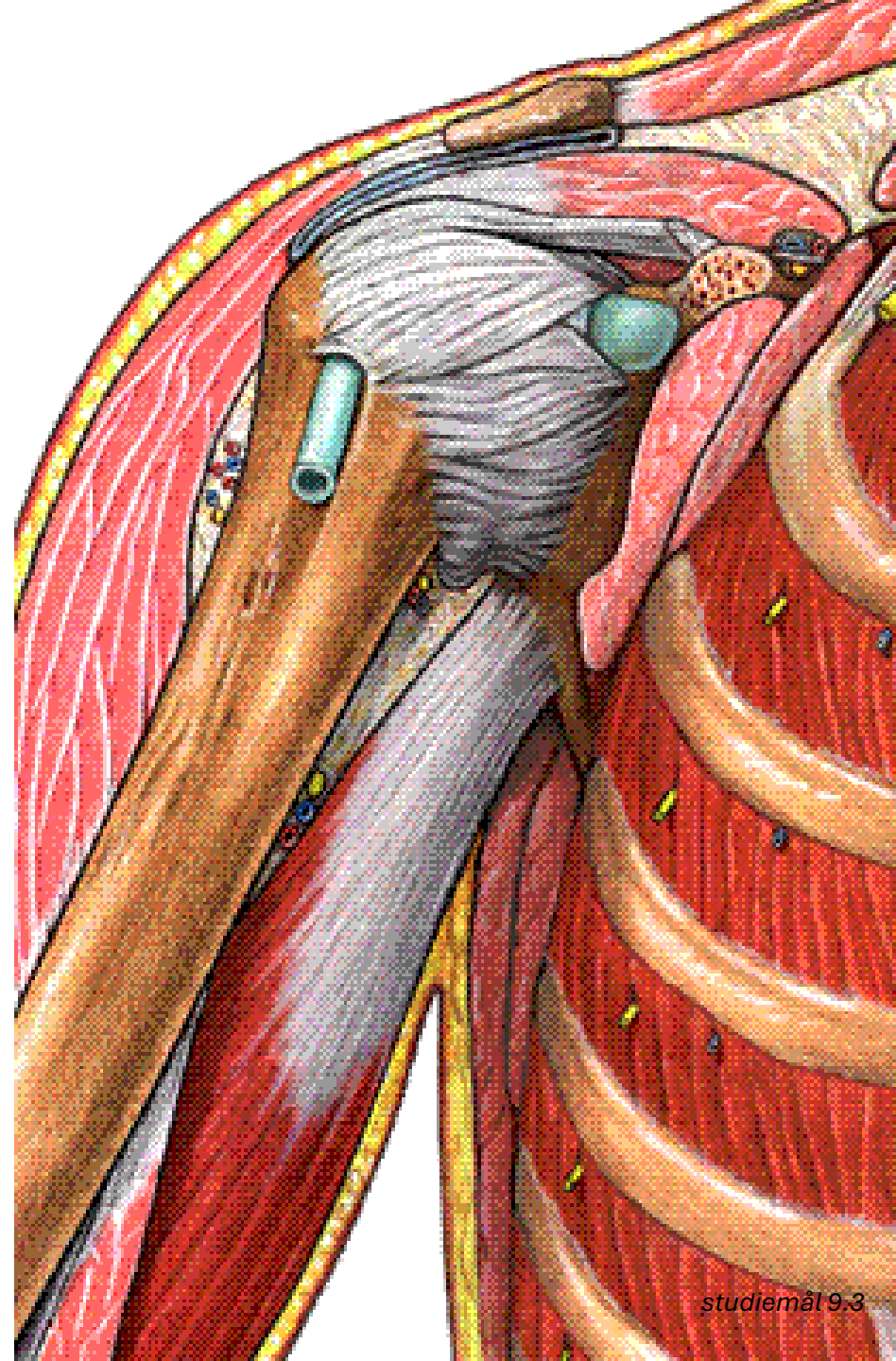
Led

- Ægte led (synoviale):
 - Indskudt ledhule, aflukket fra omgivelserne
 - 1, 2 ell. 3 frihedsgrader
- Uægte led:
 - Forbundet af støttevæv



Ægte led (synoviale led)

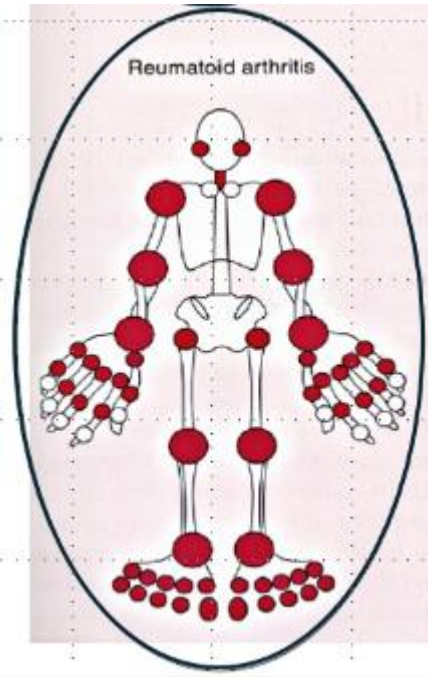
- Ledhule ”fyldt” med ledvæske (synovialis)
- Ledbrusk (hyalin)
- Ledkapsel
 - Membrana synovialis
 - Membrana fibrosa



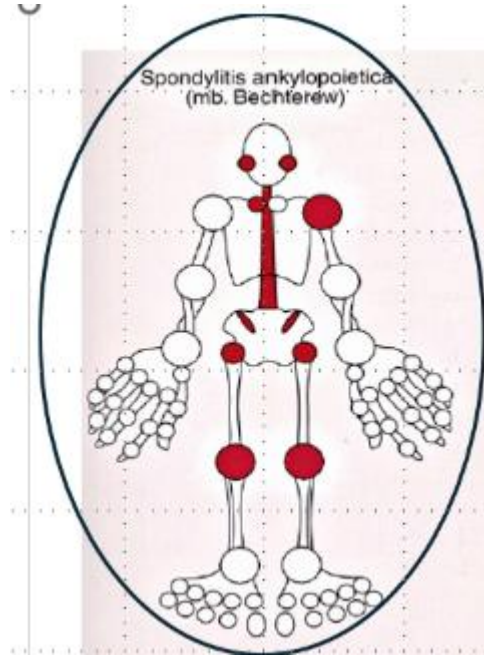
F2: Inflammatoriske ledsygdomme

- **Vævsskade** som følge af inflammation.
- **Betændelse:** Hævelse, smerte, rødme, varme, stivhed/nedsat funktion.
- **Invasion af hvide blodlegemer** (først neutrofile, siden mononukleære).
- Udskillelse af **cytokiner** (blodcellernes signalstoffer).
- Dannelse af **C-reaktivt protein (CRP)** i leveren.
- **Autoimmune** – immunsystemet angriber egen kroppen.
- Ofte angreb på blodkar (**vaskulit**).
- Træthed, sygdomsfornemmelse, evt feber.

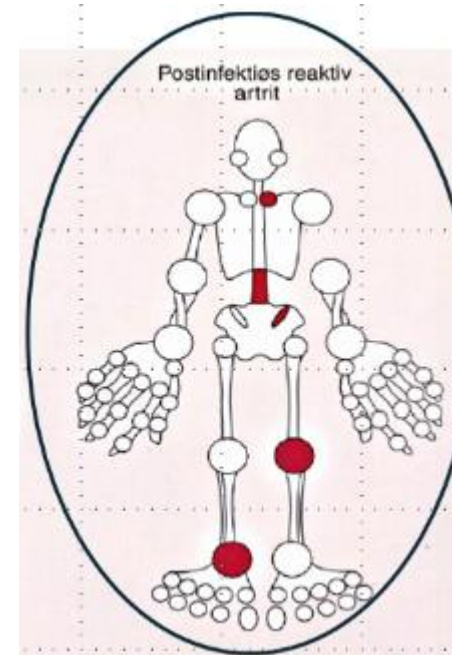
F2: Inflammatoriske ledsygdomme



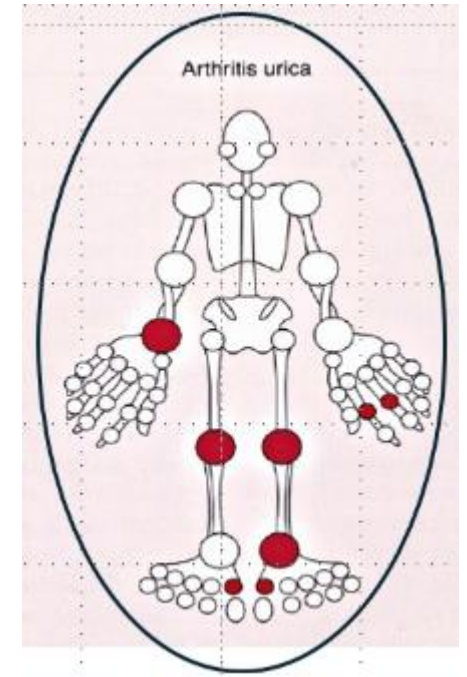
Reumatoid artrit
(Leddegigt, ægte gigt, RA)



Ankyloserende spondylit
(Rygøjlegigt)



Reaktiv artrit
(Reaktiv gigt)



Arthritis urica
(Urinsyregigt, gout)

Hvilke forskelle i ledmønster kan I se?

Reumatoid artrit: Definition + forekomst



Definition

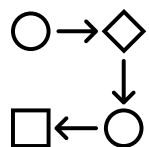
Reumatoid artrit er en **kronisk autoimmun ledsygdom**, der giver **symmetrisk inflammation** i hænder (håndled, kno- eller mellemled i fingre), fødder og andre perifere led.



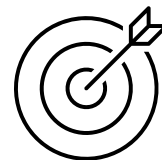
Forekomst

- Rammer ca. 1 % af voksne.
- Den hyppigste form for “ægte gigt” (dvs. inflammatorisk artrit).
- Kvinder 2–3 gange oftere end mænd.
- Debut typisk i 20–40-årsalderen.

Reumatoid artrit: Patogenese + ætiologi



Patogenese



Ætiologi

Immunforsvaret angriber synovialis*



Kronisk inflammation



Erosion (gnav) af brusk og knogle

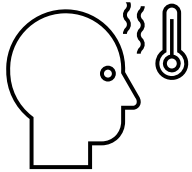
- Genetiske faktorer (HLA-DR4 & familiær disposition).
- Miljøfaktorer (rygning).
- Mulig infektiøs trigger (virus/bakterier).
- Lang præklinisk fase - autoimmunitet udvikles gradvist før symptomer.

* Ledhinden

Reumatoid artrit

- <https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/knogler-muskler-og-led/sygdomme/leddegigt/leddegigt-oversigt/>

Reumatoid artrit: Symptomer og kliniske fund



Symptomer

- **Symmetrisk** involvering af mange småled i hænder/fødder
- Smerte, ømhed og hævelse (varme, ødem og morgenstivhed)
- Funktionsnedsættelse (muskelkraft+bevægelighed ↓ + træthed)

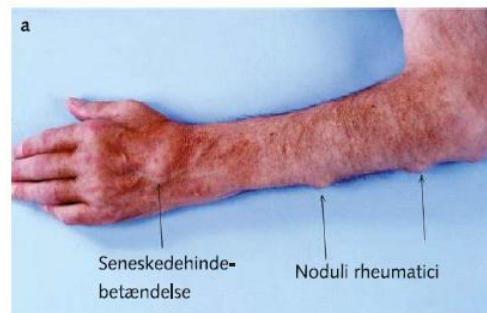


Fund

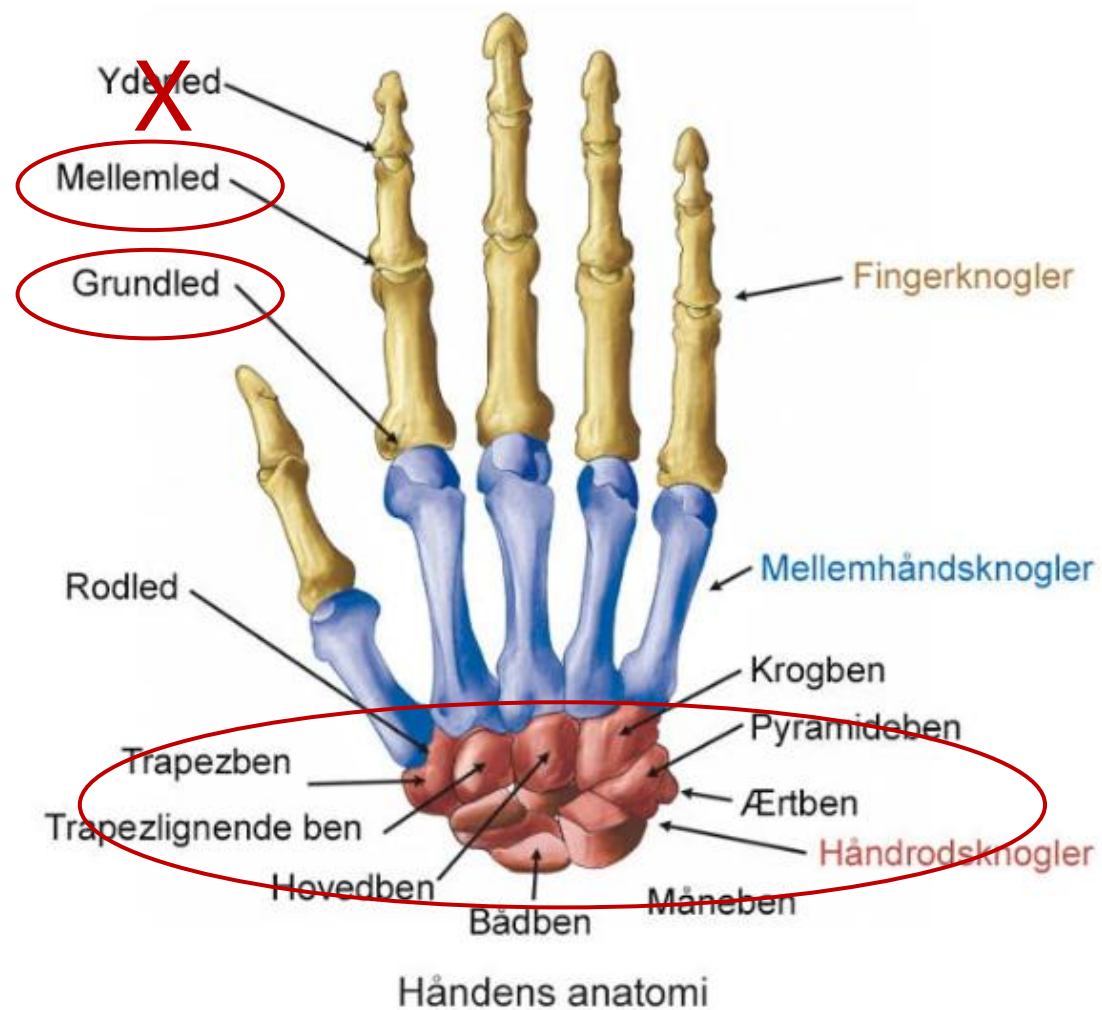
- Deformiteter/ledskred/fejlstillinger ved langvarig sygdom
- Seneruptur (pga. betændelse i seneskeder)
- Bursitis (slimsækbetændelse)
- Systemiske manifestationer:
 - Noduli (gigtknuder)
 - Træthed
 - Vaskulit (betændelse i blodkar → risiko for hjerte-karsygdomme)



Figur 3.1. Reumatoid arthritis (leddegigt) angriber håndled og fingrenes grundled og mellemlid (aldrig yderled). a) I den akutte fase med udtalt hævelse pga. betændelse, b) efter mange års sygdom kan der komme fejlstillinger omkring leddene.



Figur 3.2. a) Noduli rheumatici på underarmen. Seneskedehindebetændelse på håndryggen. b) Hævelse af bursa (slimsæk) over albuen ("studenteralbue") kan opstå ved gentagne tryk.



Reumatoid artrit: Diagnostik



Diagnostik

- ACR/EULAR-klassifikationskriterier
- Blodprøver
 - Reumafaktor (RF), autoantistof; findes hos ca. 70–80 %
 - Anti-CCP-antistoffer (peger stærkt på RA)
 - Inflammationsmarkører
 - SR (sænkingsreaktion)
 - CRP
 - ofte også ændringer i leukocytter/erythrocytter
- Billeddiagnostik
 - Røntgen
 - Ultralyd

Tabel 3.1. ACR/EULAR 2010 klassifikationskriterier for reumatoid artrit. Målgruppen er patienter med nyopstået synovitis (inflammation i ledhinden) i mindst ét led, der ikke bedre kan forklares ved anden sygdom. Seks eller flere ud af 10 mulige point er nødvendige for at klassificere patienten som havende reumatoid artrit. Patienter klassificeres også som havende reumatoid artrit, hvis de har en længere sygehistorie, der er forenelig med reumatoid artrit, og ved røntgenundersøgelse har erosioner (udstansninger i den lednære knogle) typiske for reumatoid artrit. IgM-RF: IgM-reumafaktor, anti-CCP: antistof mod cyklisk citrullineret peptid, CRP: C-reaktivt protein og SR: sænkingsreaktionen.

Ledinvolvering (0-5)

1 stort* led
2-10 store led
1-3 små led
4-10 små led
> 10 led (mindst ét lille led)

Serologi (undersøgelse af serum) (0-3)

Ingen IgM-RF eller anti-CCP
Mindst ét antistof i lav titer
Mindst ét antistof i høj titer

Akut faserespons (0-1)

Ingen CRP- eller SR-forhøjelse
Abnorm CRP eller SR

Varighed af symptomer (0-1)

< 6 uger
≥ 6 uger

*Ved store led forstås skuldre, albuer, knæ og fodled.

Reumatoid artrit: Diagnostik



Diagnostik

- Kliniske kriterier (ACR/EULAR)
- Blodprøver (RF, anti-CCP, CRP/SR)
- Billeddiagnostik (røntgen/ultralyd)

Tabel 3.1. ACR/EULAR 2010 klassifikationskriterier for reumatoid artrit. Målgruppen er patienter med nyopstået synovitis (inflammation i ledhinden) i mindst ét led, der ikke bedre kan forklares ved anden sygdom. Seks eller flere ud af 10 mulige point er nødvendige for at klassificere patienten som havende reumatoid artrit. Patienter klassificeres også som havende reumatoid artrit, hvis de har en længere sygehistorie, der er forenelig med reumatoid artrit, og ved røntgenundersøgelse har erosioner (udstansninger i den lednære knogle) typiske for reumatoid artrit. IgM-RF: IgM-reumafaktor, anti-CCP: antistof mod cyklisk citrullineret peptid, CRP: C-reaktivt protein og SR: sænkingsreaktionen.

Ledinvolvering (0-5)

1 stort* led
2-10 store led
1-3 små led
4-10 små led
> 10 led (mindst ét lille led)

Serologi (undersøgelse af serum) (0-3)

Ingen IgM-RF eller anti-CCP
Mindst ét antistof i lav titer
Mindst ét antistof i høj titer

Akut faserespons (0-1)

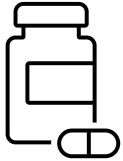
Ingen CRP- eller SR-forhøjelse
Abnorm CRP eller SR

Varighed af symptomer (0-1)

< 6 uger
≥ 6 uger

*Ved store led forstås skuldre, albuer, knæ og fodled.

Reumatoid artrit: Behandling



Behandling

Mål: dæmpe inflammation og forhindre ledske.

- DMARD* (fx methotraxat; bremser sygdomsaktivitet)
- NSAID** (fx Ipre, naproxen; symptomlindring)
- Binyrebarkhormon (glukokortikoider, som tablet eller indsprøjtning)
- Biologiske midler (fx TNF-a hæmmer; målrettet immunnæmning)
- Fysioterapi + patientuddannelse – funktion og egenhåndtering
- Varmtvandstræning, Massage
- Kirurgi – ved svær ledske

*Disease-Modifying Anti-Rheumatic Drugs (altså: sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler)

**Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (altså: ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler)

Reumatoid artrit: Følgesygdomme + prognose



Følgesygdomme

- Lokalt i bevægeapparatet:
 - Seneruptur (pga. inflammation i seneskeder/ledhinde)
 - Muskelsvaghed og atrofi
 - Progressive ledskeer og deformiteter
- Systemiske følgesygdomme:
 - Inflammation → øger risiko for hjerte-kar-sygdom



Prognose

- Ofte kronisk: sygdommen varer livet ud med perioder af aktivitet og ro
- Sjældnere: enkeltstående tilfælde, som klinger af efter få måneder uden længerevarende ledsskade
- Ubehandlet → tiltagende ledsskade og funktions tab (livslængde afkortes med ca. 10 år)
- Moderne behandling → god prognose, ofte lav aktivitet eller remission (sygdommen under kontrol/"sover")

Reumatoid artrit: Byrde for patient og samfund



Byrde

- For patienten:
 - Smerter og nedsat funktion
 - Tab af erhvervsevne
 - Psykiske belastninger: ensomhed og depression
- For samfundet:
 - Øgede udgifter til pension og sociale foranstaltninger
 - Øgede udgifter til medicin og behandling

RA → smerter, funktionsnedsættelse, tab af arbejdsevne, psykisk belastning og store samfundsomkostninger

Reumatoid artrit: Opsamling og nøglepunkter

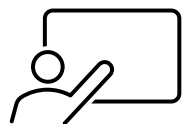
Nævn 3 karakteristika, der er særligt typiske for reumatoid artrit.

Tænk fx i:

- sygdomstype
- ledmønster
- forløb eller behandling



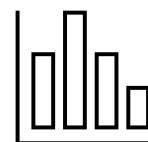
Rygsøjlegigt (ankyloserende spondylit): Definition + forekomst



Definition

Rygsøjlegigt (ankyloserende spondylit ~Bechterews sygdom) er en **kronisk inflammatorisk gigtsygdom**.

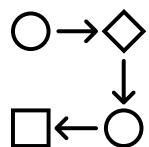
Angriber **rygsøjle-/bækkenled** og centralt placerede led (bryst, hofte, skulder).



Forekomst

- Rammer ca. 0,1% af befolkningen.
- Stærkt associeret med HLA-B27 (95% af patienterne har denne vævstype).
- Mand/kvinde ratio: 5/1.
- Typisk en ung, mand, 20–40 år.

Rygsøjlegigt (ankyloserende spondylit): Patogenese + ætiologi



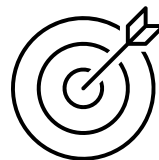
Patogenese

Inflammatoriske angreb primært:

- Rygsøjlen og bækkenled (sacroiliacaled).
- Senehæfter.
- Efter angreb → opheling → knogledannelse.

Sammenvoksning af knogler → **stivhed** i ryg og bækken.

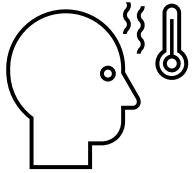
Til forskel fra RA ses ofte **normale blodprøver** og **ingen** gigtknuder.



Ætiologi

- Genetisk disposition: 95% af patienterne har vævstype HLA-B27 (findes hos 9% af befolkningen).
- Miljøfaktorer (fx virusinfektion).

Rygsøjlegigt (ankyloserende spondylit): Symptomer og kliniske fund



Symptomer

- Ømhed over bækkenet.
- Nedsat bevæglighed.
- Smerter i lænd og ryg; værst om natten.



Fund

- Røntgenforandringer.
- Foroverbøjning i ryggen.
- Deformitet af ryggen i løbet af 10-30 år (kyfosing).
- Evt stivnet bryst-/kraveben → hæmning af lungefunktionen.

Rygsøjlegigt (ankyloserende spondylit): Diagnostik

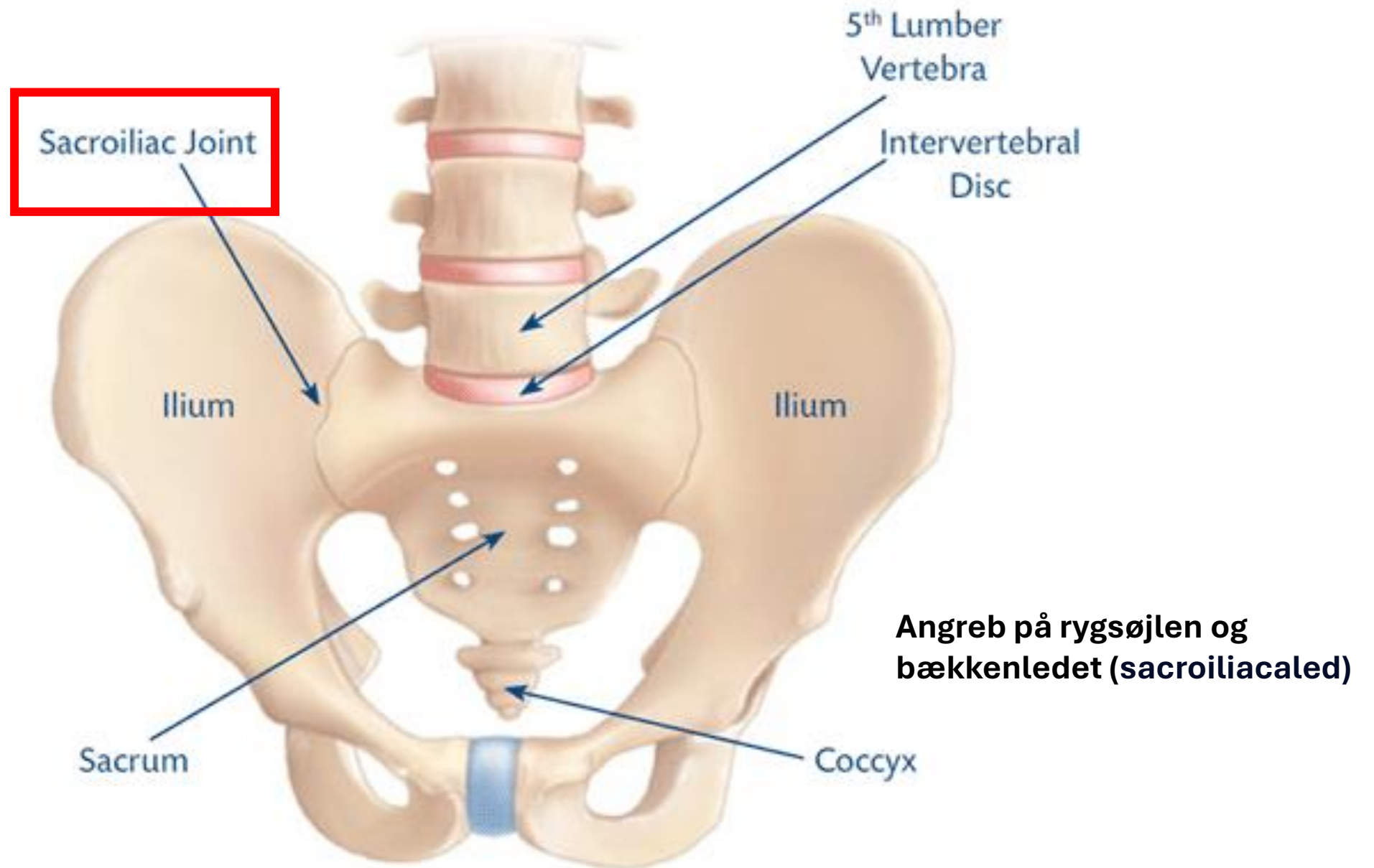


Diagnostik

- Billeddiagnostik (røntgen/MR)

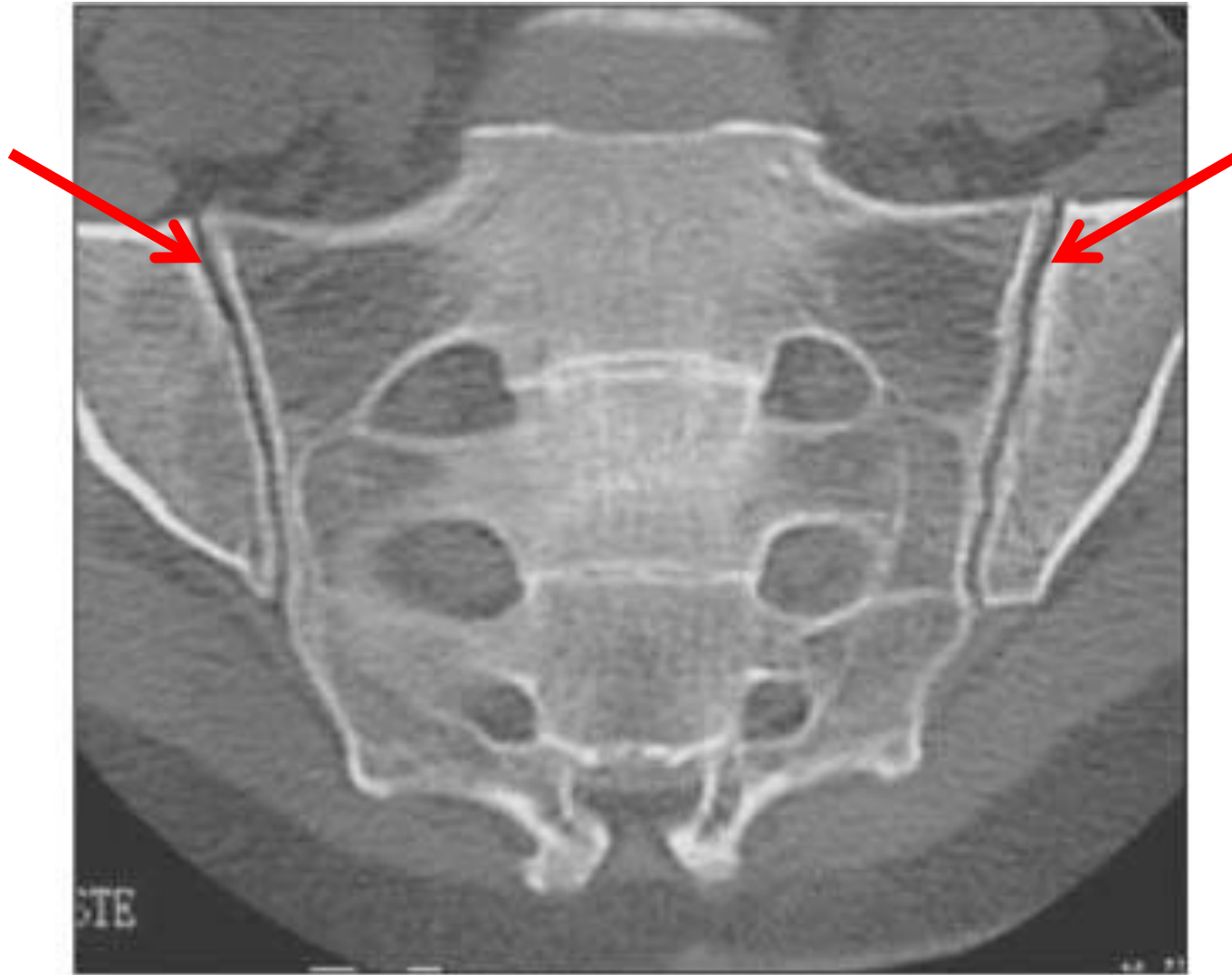


Sacroiliac joint (*synovial, plane joint*).

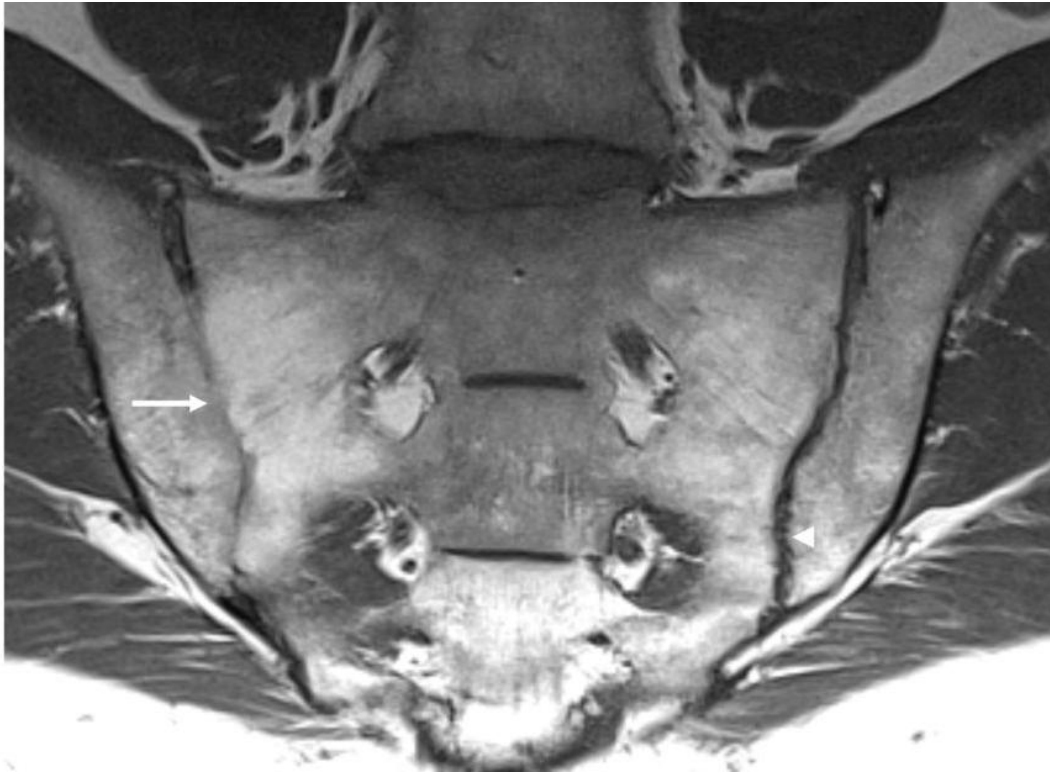


Sacroiliac joint (*synovial, plane joint*).

Normal



CT coronal oblique view showing preserved and symmetrical joint spaces, with regular surfaces. The joint space is considered as normal between 2.0 and 4.0 mm.
<http://dx.doi.org/10.1590/S0100-39842007000100012>



Sacroiliac joint (*synovial, plane joint*)

Partial ankylosis

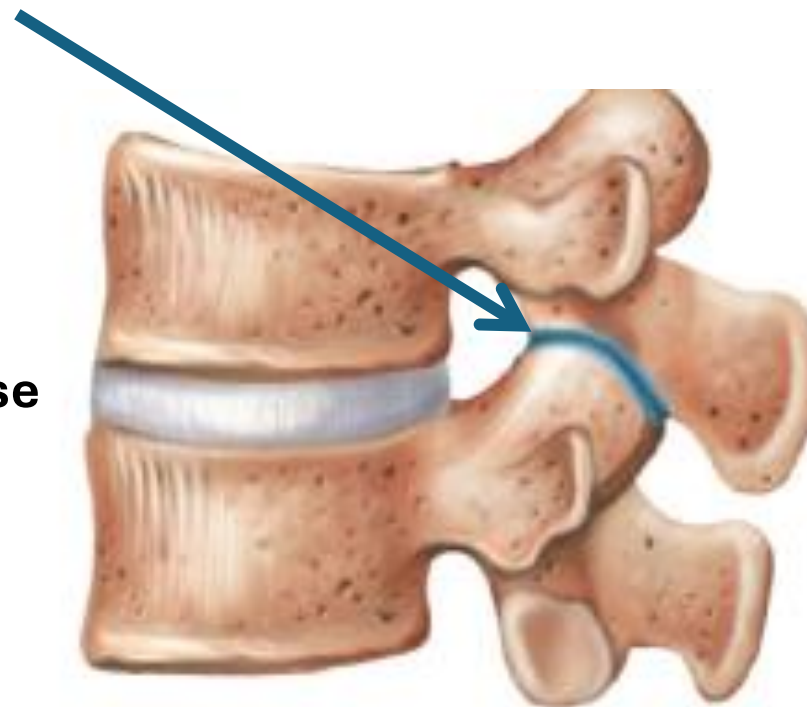
Denis Poddubnyy et al. J Rheumatol 2013;40:1557-1565



Inflammation i grænsefladen mellem brusk/ledbånd og knogle.

Synovialled

Bruskforbindelse



Vertebrae

Fibrøse led

meget lidt eller ingen bevægelse, f.eks. kraniet

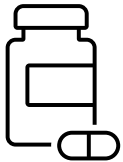
Bruskled

stram forbindelse mellem to knogler, meget begrænset bevægelse, f.eks. mellemvertebralskiver

Synoviale led

frit bevægelige led, der indeholder ledvæske i en ledkapsel: de fleste knogler i det appendikulære skelet

Rygsøjlegigt (ankyloserende spondylit): Behandling



Behandling

Mål: dæmpe smerter og modvirke stivhed.

- Træning!
- NSAID^{**} (fx Ipren, naproxen; symptomlindring)
- Fysioterapi + patientuddannelse – funktion og egenhåndtering
- Varmtvandstræning
- Biologiske midler (fx TNF-a hæmmer; målrettet immunhæmning ved udtalte angreb)

^{**}Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (altså: ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler)

Rygsøjlegigt (ankyloserende spondylit): Følgesygdomme + prognose



Følgesygdomme

- Kraftig foroverbøjning som følge af rygstivheden → hæmmer udsyn
- Stivnet brystkasse → hæmmer lungefunktion



Prognose

- Kronisk: sygdommen varer livet ud med mangeårige rygsmerter
- God prognose ift. livslængde

Rygsøjlegigt (ankyloserende spondylit): Byrde for patient og samfund



Byrde

- For patienten:
 - Mangeårige rygmerter
 - Nedsat funktion/bevægelighed

Rygsøjlegigt : Opsamling og nøglepunkter

Nævn 2–3 karakteristika for rygsøjlegigt.

Tænk fx i:

- den typiske patient
- hvilke led rammes
- hvad gør sygdommen anderledes end RA

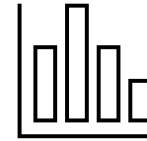


Reaktiv artrit: Definition + forekomst



Definition

En immundrevet
ledinflammation (steril artrit*)
der opstår **efter en infektion** et
andet sted i kroppen.

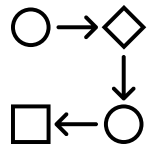


Forekomst

- Ca. 2300 tilfælde/år i DK.
- Relativ sjælden.
- Hyppigst hos unge voksne.

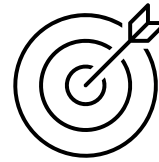
*Dvs uden mikroorganismer til stede.

Reaktiv artrit: Patogenese + ætiologi



Patogenese

- Udløses typisk 2-3 uger efter infektion (tarm, urinveje eller kønsorganer).
- Ingen bakterier i leddet.
- Immunforsvaret reagerer “fejlagtigt” på infektionen → krydsreaktion mod led.



Ætiologi

- Udløst af virus og bakterier (Tabel 3.2)
- Øget risiko hos personer med HLA-B27 vævstype.

Tabel 3.2. Reaktive artritter efter virale eller bakterielle infektioner.

A. Reaktiv artrit efter virus.

Virustype

Hepatitis B

Polyartikulære symptomer, kun diskret synovit.

Parvovirus

Symmetriske, polyartikulære symptomer i små led, især hos kvinder, ofte kun diskret synovit, evt. kun artralgie.

Rubella (røde hunde)

Både små og store led, kun diskret synovit, snarede artralgie, ses især hos voksne kvinder.

Rubella-vaccine

Artralgie hos op til 5 % af børnene.

HIV

Entesopati-lignende sygdom (smerter svt. sene-fæster). Kan ledsages af Sjögrens syndrom (se dette, side 40).

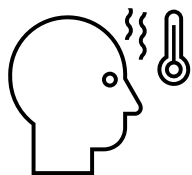
Monartrit i knæled ses.

B. Reaktiv artrit efter bakterier

Bakterie

Campylobacter, Salmonella, Yersinia, Shigella.

Reaktiv artrit : Symptomer og kliniske fund



Symptomer

- **Akut** opståede **ledsmerter**.
- Hævede og ømme led (typisk knæ, ankler, fødder).
- Smerter ved senefæster (enthesitis).
- Ryg-/bækkensmerter hos nogle.
- Træthed, feber, utilpashed.
- Svie ved vandladning(**urethritis**).
- Øjenirritation/øjensmerter (**konjunktivitis**).

Triade (Reiters syndrom):

Øjenbetændelse+ urinrørsbetændelse + ledsmerter

"Can't see, can't pee, can't climb a tree"



Fund

- **Asymmetrisk** ledinflammation i få store led).
- Hævelse, varme og nedsat bevægelighed i led.
- Dactylitis (pølsefinger / pølsetå)
- Entesit-fund: ømhed ved senhæfter (fx Achilles).
- Konjunktivitis ved objektiv undersøgelse.
- Hudforandringer (keratoderma blennorrhagicum).
- CRP/ledvæske/ røntgen er ofte normale.

Reaktiv artrit : Diagnostik og behandling



Diagnostik

- Klinisk diagnose + nylig infektion.
- Blodprøver ofte normale (evt. let ↑CRP/SR).
- HLA-B27 kan støtte.
- Test for STI*/tarminfektion.
- UL: ved hævelse/enthesitis.
- RTG: ved langvarige symptomer.



Behandling

- NSAID (førstevalg).
- Evt. steroidinjektion i angrebne led.

*Sexually Transmitted Infection ~ seksuelt overført infektion.

Reaktiv artrit: Følgesygdomme + prognose



Følgesygdomme

- Kronisk artrit forløb hos ganske få.
- Tilbagevendende ryg/ledbesvær.



Prognose

- Prognosen er god.
- Flertallet bliver raske.

Reaktiv artrit: Byrde for patient og samfund



Byrde

Reaktiv artrit → smerte og funktionsnedsættelse; få bliver kroniske.

Urinsyregigt: Definition + forekomst



Definition

Urinsyregigt (arthritis urica) er en **inflammatorisk ledsygdom** udløst af **urinsyrekrystaller** udfældet i leddet.



Forekomst

- Prævalens 1-2% (mænd/kvinder 10/1)

< Alene i vildmarken Australien: Presset ...

SÆSON 3 EPISODE 9 | 54M

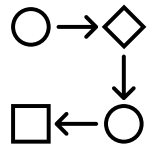
MUZZA

63 år

Victoria

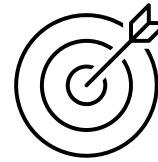
Ja, jeg bøvler med
en omgang podagra.

Urinsyreigt: Patogenese + ætiologi



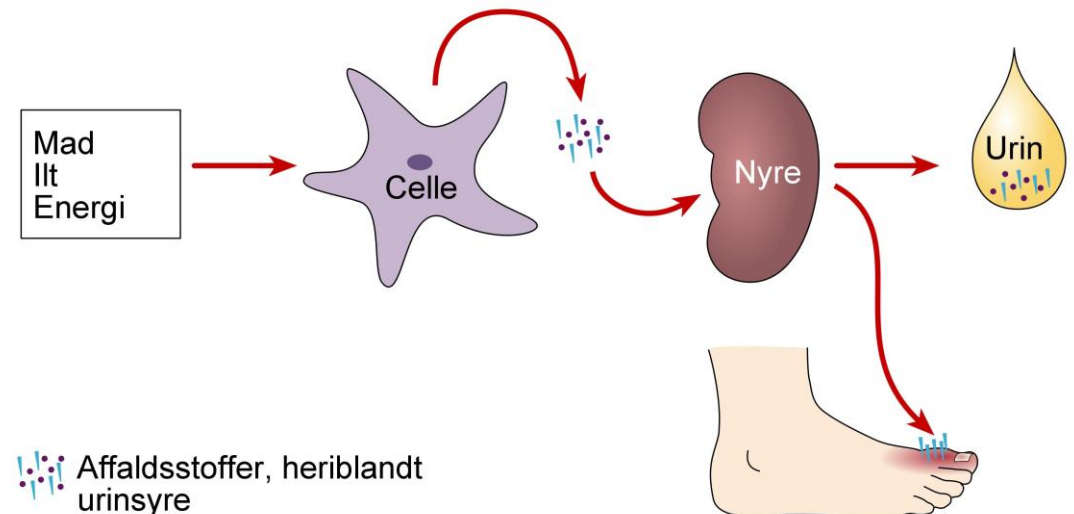
Patogenese

- Forhøjet **urinsyre** i kroppen → **aflejring som uratkrystaller** i hud/led (tofi).
- Frigjorte **krystaller** i leddet → **inflammatorisk** reaktion.
- Giver akutte, meget smertefulde ledanfald.



Ætiologi

- Nedsat udskillelse af urinsyre - fx pga nedsat nyrefunktion (hyppigst).
- Øget produktion af urinsyre (purinrig kost, alkohol).



Urinsyregigt: Symptomer og kliniske fund



Symptomer

- Akut, meget smertefuldt led
- Rødme, varme, hævelse
- Nedsat funktion og udtalte smerter ved fx gang.
- Kronisk: dannelse af tofi.



Figur 3.6. Urinsyregigt angriber typisk storetåens grundled. A) Rødme ved det akutte anfald. B) Ømheden er meget udtalt; bemærk, at man kan skimte urinsyreaflejring over leddet. C) Enkelte får kraftige aflejringer af urinsyre.



Fund

- Klassiske tegn på lokal inflammation: rødme, varme, hævelse, smerter og nedsat funktion.
- Hyppigst storetåens grundled.
- Tofi (hårde knuder af uratkrystaller).
- Urinsyre i blodprøver ofte forhøjet.

Urinsyregigt: Diagnostik og behandling



Diagnostik

- Undersøgelse af ledvæske (urinsyrekrystaller, hvide blodlegemer) og blodprøver (urinsyre).



Behandling

Mål: Reducere urinsyreindholdet med medicin og kostændringer

Akut:

- NSAID.
- Kolkicin (indsprøjtning i ledet)

Kronisk:

- Undgå purinrig mad.
- Øg væskeindtaget og pH i urinen.
- Allopurinol (hindrer dannelse af urinsyre).

Urinsyreigt: Følgesygdomme + prognose



Følgesygdomme

- Det akutte anfald svinder ubehandlet efter nogle uger og 50% oplever kun et enkelt anfald.
- Få udvikler kronisk form med tilbagevendende ledproblemer.
- Nyresten (uratsten).



Prognose

- God ved korrekt behandling.
- De fleste bliver anfaldsfrie ved urinsyresænkende behandling.
- Ubehandlet → risiko for kroniske ledsmerter og tofi-dannelse.

Urinsyregigt: Byrde for patient og samfund



Byrde

Urinsyregigt → intense smerter, men oftest forbigående anfald; kun få udvikler kronisk sygdom og længerevarende funktionspåvirkning.

Reaktiv artrit og Urinsyregigt: Opsamling og stikord

Nævn 2–3 karakteristika ved **reaktiv artrit** og **urinsyregigt**.

Diskuter:

- Ledangreb
- Symptomer
- Udløsende faktorer

